

# CEFALEIA



## ROTINA CLÍNICA

**Modelos de evolução**

## **ANAMNESE: TENSIONAL**

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE CEFALÉIA EM OPRESSÃO, HOLOCRAIANA, DE MODERADA INTENSIDADE.

NEGA FEBRE, NEGA NÁUSEAS E/OU VÔMITOS.

NEGA FOTO OU FONOFOBIA.

NEGA OUTRAS QUEIXAS.

RELATA EPISÓDIO SIMILAR OCORRIDO HÁ.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



## EF: TENSIONAL

**GERAL:** BEG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

**NEURO:** LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

**AR:** MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O<sub>2</sub>: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

**ACV:** RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

**ABD:** ATÍPICO, RHA PRESENTES NOS 4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.

**MMII:** SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



## HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

CEFALEIA TENSIONAL, SEM SINAIS DE ALARME

- **CONDUTA:**

- SINTOMÁTICOS POR VIA ORAL AGORA
- REAVALIAÇÃO APÓS
- FORNEÇO RECEITA MÉDICA
- FORNEÇO ATESTADO MÉDICO
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL
- ORIENTO SINAIS DE ALARME E, EM CASO DE PRESENÇA DESTES, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE



## ANAMNESE: MIGRÂNEA

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE CEFALÉIA PULSÁTIL, À DIREITA/ESQUERDA, DE FORTE INTENSIDADE, ASSOCIADA A FOTOFOBIA/FONOFOBIA, NÁUSEAS E/OU VÔMITOS SEM ELEMENTOS PATOLÓGICOS.

NEGA FEBRE.

NEGA OUTRAS QUEIXAS.

RELATA EPISÓDIO SIMILAR OCORRIDO HÁ.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



## EF: MIGRÂNEA

**GERAL:** REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL. FACE DE DOR

**NEURO:** LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

**AR:** MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O<sub>2</sub>: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

**ACV:** RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

**ABD:** ATÍPICO, RHA PRESENTES NOS 4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.

**MMII:** SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



## HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

CEFALEIA DO TIPO MIGRÂNEA/ENXAQUECA,  
SEM SINAIS DE ALARME

- **CONDUTA:**

- SINTOMÁTICOS EV AGORA
- HIDRATAÇÃO VO OU EV AGORA
- REAVALIAÇÃO APÓS
- FORNEÇO RECEITA MÉDICA
- FORNEÇO ATESTADO MÉDICO
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO  
AMBULATORIAL
- ORIENTO SINAIS DE ALARME E, EM CASO  
DE PRESENÇA DESTES, PROCURAR  
ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE



## ANAMNESE: SALVAS

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE CEFALEIA À DIREITA/ESQUERDA, DE FORTE INTENSIDADE, ASSOCIADA A HIPEREMIA CONJUNTIVAL/LACRIMEJAMENTO IPSILATERAL, PTOSE PALPEBRAL, CONGESTÃO NASAL E RUBOR FACIAL IPSILATERAL. NEGA FEBRE.

NEGA OUTRAS QUEIXAS.

RELATA EPISÓDIO SIMILAR OCORRIDO HÁ.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**





## EF: SALVAS

**GERAL:** REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL. FACE DE DOR, PRESENÇA DE LACRIMEJAMENTO E RUBOR FACIAL À DIREITA/ESQUERDA.

**NEURO:** LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

**AR:** MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O<sub>2</sub>: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

**ACV:** RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

**ABD:** ATÍPICO, RHA +4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.

**MMII:** SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



## HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

CEFALEIA DO TIPO EM SALVAS, SEM SINAIS DE ALARME

- **CONDUTA:**

- OXIGÊNIO EM MÁSCARA DE ALTO FLUXO AGORA
- SUMATRIPTANO SUBCUTÂNEO OU INTRANASAL AGORA
- REAVALIAÇÃO APÓS
- FORNEÇO RECEITA MÉDICA
- FORNEÇO ATESTADO MÉDICO
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL COM NEUROLOGISTA
- ORIENTO SINAIS DE ALARME E, EM CASO DE PRESENÇA DESTES, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE



## CEFALEIA SECUNDÁRIA

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE CEFALeia DE FORTE INTENSIDADE, ASSOCIADA A SINAL DE ALARME (“RED FLAG”) - DESCRIVER EM DETALHES.

NEGA FEBRE.

NEGA EPISÓDIOS PRÉVIOS SIMILARES A ESTE.

NEGA OUTRAS QUEIXAS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



## CEFALEIA SECUNDÁRIA

**GERAL:** REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL. FACE DE DOR.

**NEURO:** LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

**AR:** MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O<sub>2</sub>: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

**ACV:** RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

**ABD:** ATÍPICO, RHA +4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.

**MMII:** SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



## HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

CEFALEIA SECUNDÁRIA COM PRESENÇA DE SINAL DE ALARME (ESPECIFICAR)

- **CONDUTA:**

- ANALGESIA OTIMIZADA
- SOLICITO TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE
- MANTENHO PACIENTE EM OBSERVAÇÃO
- REAVALIAÇÃO APÓS

